TomSigrist.ch
HYPNOSETHERAPIE & AUSBILDUNG

hypno2

der aufbaukurs

mit tom sigrist,
evelyn sigrist &
regina stahel

von dr. erich zulauf
& tom sigrist

Inhaltsverzeichnis

1 Beziehung in Trance ... 4
1.1 Die hypnotische Beziehung ... 4
1.2 Unterscheidungen der grundsätzlichen Beziehungsebenen ... 5
1.3 Die innere Beziehung des bewussten Verstandes mit dem unbewussten Verstand - des Coachs ... 5
Übung 1: Grundzustand – Mitte - Hara ... 7
Übung 2: Wasserkraftwerk-Metapher ... 8
2 Beziehung des Bewussten mit dem Unbewussten im Klienten - aus Sicht des Coach ... 9
2.1 Unbewusstsein, Vorbewusstsein und Bewusstsein ... 9
3 Schmerzmanagement ... 10
3.1 Zentrales Wissen rund um den Schmerz ... 10
3.1.1 Schmerz – eine Definition ... 10
3.1.2 Der sensomotorische Kortex ... 11
3.1.3 Körperlicher oder zentraler Schmerz ... 12
3.2 DEEP STATE Hypnose ... 13
3.3 Hypnotische Phänomene im Schmerzmanagement ... 17
3.3.1 Analgesie ... 17
3.3.2 Anästhesie ... 17
3.3.3 Amnesie ... 18
3.3.4 Partielle Dissoziation ... 18
3.3.5 Totale Dissoziation ... 18
3.3.6 Zeitliche Re-Orientierung ... 18
3.3.7 Halluzinieren (kinästhetisch) ... 18
3.4 Übung 3: Analgesie ... 19
3.5 Komplexe Ansätze im Schmerzmanagement ... 20
3.5.1 Umdeutung ... 20
3.5.2 Symbolische Transformation ... 20
3.5.3 Schmerzbezogene Metaphern ... 20
3.5.4 Einstreutechnik ... 20
3.6 Schmerzmanagement mit Hypnose ... 21
4 Sprachmuster der hypnotischen Kommunikation II ... 23
4.1 Die wichtigsten Sprachmuster ... 23
4.1.1 Verneinungen (verneinte Befehle) ... 23
4.1.2 Frage am Ende des Satzes (Tag Questions) ... 23
4.1.3 Stopp ... 23
4.1.4 Verkettung von modalen Operatoren ... 23
4.1.5 Versuche vergeblich (zu verhindern) ... 24
4.1.6 Den Namen aussprechen ... 24
4.1.7 Mehrdeutigkeiten ... 24
4.1.8 Worte welche Vorannahmen verstecken - Magische Worte, welche Akzeptanz bewirken ... 24
a) Oder ... 24
b) Zeitwörter ... 25

c) W-Fragen ... 25
d) Kommentierende Adjektive und Adverbien ... 25
4.2 Bindungen und Doppelbindungen ... 26
4.2.1 Bindungen ... 26
4.2.2 Doppelbindungen ... 26
4.2.3 Zeit und Doppelbindung ... 26
4.2.4 BW / UBW und Doppelbindung ... 26
4.2.5 Doppel-Dissoziations-Doppelbindung ... 27
5 Mit Hypnose und High Quality Information zu Lösungen in Trance ... 28
5.1 High Quality Information ... 28
5.2 Wie magisch ist Hypnose? ... 29
5.3 Symbolisches und metaphorisches Denken ... 30
5.3.1 Konkret oder symbolisch ... 31
5.4 Übung 5: Symbolische Transformationen ... 32
5.5 Mikrometaphern ... 33
6 Konversationelle Hypnose in der E-Mail-Kommunikation ... 34
6.1 Übung 7: Hypno-E-Mailing ... 34
7 Dissoziation ... 41
7.1 Veränderung von Dissoziationsmustern ... 41
7.2 Dissoziationen Re-assoziieren: Pattern A ... 42
7.3 Übung 8: Jäger des verlorenen Schatzes ... 43
8 Mit Hypnose und High Quality Information zu Tranceformation 2 ... 44
8.1 Ein Hauch von Schamanismus ... 44
8.2 Übung 9: Be it! ... 45
8.3 Transneuronale Welten ... 46
8.4 Die wirksame Trance ... 47
9 Wie sag‘ ich es meinem Kinde? (WSK) ... 48
9.1 Übung 10: Wie sag‘ ich es meinem Kinde? (WSK) ... 50
10 Symbolisch, metaphorisch kommunizieren ... 52
10.1 Übung 11: In Trance erzählen ... 52
10.2 Übung 12: Geschichten, die heilen ... 53
11 4-Steps ... 55
11.1 Übung 13: Das 4-Steps-Programm des Auftritts ... 55
11.2 Übung 14: Vorbahnen ... 56

1 Beziehung in Trance

1.1 Die hypnotische Beziehung

Im hypnotischen Prozess ist die **Qualität** der **Beziehungsdynamik** zwischen dem Coach und dem Klienten* - wie auch innerlich im Coach bzw. im Klienten selbst - für das Gelingen von (anspruchsvollen) **Veränderungen ausschlaggebend**.

Dabei liegt der Fokus auf der **inneren** und **äusseren Beziehung** zwischen dem **Bewusstsein** (BW) und dem **Unbewusstsein** (UBW).

Untersuchungen haben ergeben, dass es keinen Veränderungsansatz (Kommunikations- oder Therapiesystem) gibt, welcher gegenüber anderen Ansätzen, einen entscheidenden Vorteil bringt. **Ausschlaggebend** für **Veränderung** ist jedoch die **Beziehung** zwischen **Coach** und **Klient**! Folgerichtig ist das Erlernen einer ausgewogenen, inneren Beziehungskompetenz des Coaches mit sich selbst die Grundlage, auf welcher echte Veränderung beim Klienten stattfinden kann.

Obwohl meist nicht voll ausgeschöpft, offeriert uns gerade die Hypnose von ihrer Struktur her wohl die grössten Lernchancen in diesem Bereich. Denn je versierter man hypnotisiert, umso mehr fungiert man als HypnoCoach wie ein Bio-Feedbackgerät, d.h. fein abgestimmt auf das Erleben des Klienten.

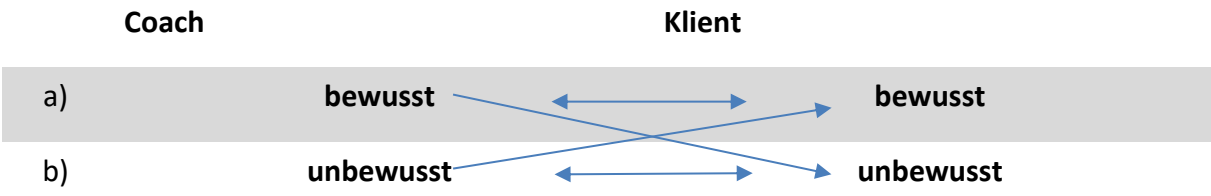
***** Die Begriffe Klient/Klientin werden zum einfacheren Verständnis des Textes sowie der Aufgaben abwechseln in weiblicher bzw. männlicher Form gebraucht.

1.2 Unterscheidungen der grundsätzlichen Beziehungsebenen

1. Innere Beziehung des **Bewusstseins** mit dem **Unbewusstsein** des **Coachs.**

2. Innere Beziehung des **Bewusstseins** mit dem **Unbewusstsein** des **Klienten.**

3. Beziehung zwischen **Coach** und **Klient.**



1.3 Die innere Beziehung des bewussten Verstandes mit dem unbewussten Verstand - des Coachs

In anspruchsvollen Veränderungsprozessen erhält die Beziehung des bewussten Verstandes des Coachs (BV-C) zu seinem eigenen, unbewussten Verstand (UBV-C) eine besondere Bedeutung. Dem ist so, weil die Voraussetzung dafür, dass der Klient während der Hypnose das Optimum an Anregungen ausschöpfen kann, die innere, ausgewogene Beziehung zwischen dem bewussten sowie unbewussten Verstand im Coach selbst ist.

Deshalb ist es für den Coach auch zentral die Gewissheit zu haben, dass er sich in diesem optimalen Zustand der ausgewogenen Beziehung zwischen seinem Bewusstsein und Unbewusstsein befindet. Da wir das normalerweise nicht ständig sind, muss der Coach auch **die Fähigkeit erlernen**, sich **vor** einer hypnotischen Begegnung in diesen **ausgewogenen Zustand** zu begeben um dann auch wieder aus diesem heraus zu arbeiten.

Im Zustand des ausgewogenen Verhältnis zwischen BV-C und UBV-C erhält der Coach auch (intuitiv) Hinweise - via **spezifische Gefühle, visuellem Modus, auditivem Modus** - welche ihn darin bestärken in der Sitzung ganz mit seiner Intuition und seinem erlernten Wissen und Können verbunden zu sein.

In diesem Zustand kann es auch hilfreich sein, eine periphere Sichtweise anzunehmen und den eigenen, internen Dialog lediglich funktional zu nutzen.

➔ **Letztlich zielen wir darauf ab, dass sich im HypnoCoach eine Trance entwickelt, welche zum jeweiligen Kontext und Klienten passt.**

Die Beschäftigung des HypnoCoach mit der Entwicklung der Eigentrance ist eine wertvolle Fähigkeit, mit der er die Dynamik des (unbewussten) Zusammenspiels zwischen ihm und seinem Klienten in die gewünschte Richtung, Entwicklung steuern kann – und diese somit nicht zufällige Formen ‚auf gut Glück' annimmt.

Die ausgewogene Eigentrance des HypnoCoaches ist gleichzeitig auch Ausdruck von und ein wichtiger Schlüssel für das eigene, zunehmend automatisch und intuitiv Werden der eigenen Hypnosefähigkeit.

Da wir nicht wissen was alles, bzw. wie unterschwellig kommuniziert wird, ist es massgebend, dass wir uns in dieser (vorwiegend) intuitiven Welt differenziert verhalten. Das wird möglich, indem unsere eigene Fähigkeit Eigenanteile im Zusammenspiel mit dem Klienten zu erkennen und zu lenken zunimmt. Gleichzeitig wirken wir dabei auf unsere eigene Psychohygiene ein.

Übung 1: Grundzustand – Mitte - Hara

Grundzustand, **Mitte**, **Hara** oder auch **gefühlter Sinn für sich selbst** sind verschiedene Namen für dasselbe: Dem Gefühl bzw. dem Zustand, welcher **tragend** in uns wirkt und mit dem **Selbstsicherheit**, **Selbstwert** und **Selbstvertrauen** eng verbunden sind.

Dieser **Zustand** bildet die Grundlage für Heilung und Aufrechterhaltung der Gesundheit als auch für das interne (im selben Individuum BV/UBV) und externe (zwischen einem Individuum und jemand anderem) Beziehungsgeschehen.

Wir unterscheiden in dieser Übung das **Grundgefühl** vom **Grundzustand**. Der Grundzustand ist, im Gegensatz zum Grundgefühl, komplexer. Der Grundzustand umfasst **Gefühle, Emotionen** sowie **visuelle und auditive Assoziationen**.

1 **Grundzustand**
Im Gespräch und in leichter Trance Entsprechungen für ‚Mitte' finden, d.h. alle Assoziationen welche mit ‚gelöstem Sein', ‚in seiner Stärke ruhen', ‚in der Kraft', ‚zentriert sein' einhergehen, aufkommen lassen.

2 **Grundgefühl**
Dazu erinnert man sich in leichter Trance an Situationen, Erlebnisse und Aktivitäten in denen man sich ‚getragen', ‚in sich ruhend', eine zentrierende Stärke' gespürt hat. Für sich notieren: Die Assoziation, welche man damit verbindet.

3 **Vom Grundgefühl zum Grundzustand**
In leichter Trance bringen wir nun die Assoziationen aus (1) evtl. auch aus (2) und das erlebte Grundgefühl aus (2) zusammen. Wenn dies nicht spontan geschieht, muss ein gemeinsamer Nenner gefunden werden, d.h. ein Link der beide miteinander verbindet.
Bspw.: Wenn jemand im Kreise seiner Familie am meisten getragen erlebt und seine Assoziation der Mitte die Bergewelt ist, könnte eine passender gemeinsamer Nenner ein Chalet in den Bergen sein, wo er sich mit seiner Familie aufhält.

4 **Nutzung**
Zuerst in vertiefter Trance den Grundzustand voll in sich ausbreiten lassen und ihn dann in Erlebnisbereiche transferieren, in welchen der Grundzustand erlebt werden möchte, wie z.B. in die eigenen Aktivität als HypnoCoach.

Übung 2: Wasserkraftwerk-Metapher

Diese Übung kann sowohl als Diagnose-Instrument als auch als Intervention für sich selbst als Coach oder für den Klienten genutzt werden. Es handelt sich dabei um eine Metapher, welche sich aus Erfahrung für erstaunlich viele Menschen eignet.

1 **Thema**
Ein Problem ein Symptom, jedoch kann auf diesem Weg auch das Zusammenspiel von BW mit UBW kann abgeklärt werden.

2 **Isomorphie**
Sich denken an ein Wasserkraftwerk mit den Akzenten:
Stausee mit Zuflüssen
Staumauer
Druckröhren auf die Turbinen
Turbinen
Energieumwandlungsvorrichtung
Kontrollpult
Starkstromleitungen zu den Verteilstationen
Verteilstation
Zuleitungen zu den Häusern/Wohnungen
Anschlüsse in den Räumen

3 **Schwachstelle**
Sich von der inneren Regie auf die Schwachstelle hinweisen lassen. Bildlich aus dem Gefühl heraus etc. Assoziationen zu konkreten Lebenssituationen oder Kindheit etc. aufkommen lassen.

4 **Reparatur**
Mittels Trancearbeit im Rahmen der vorliegenden Metapher oder auch mit anderen hypnotischen Verfahren (zusätzliche Metapher, WSK etc.) die Schwachstelle ‚reparieren'.

5 **Zukunftsbezug**
Mittels posthypnotischen Suggestionen, FuturePacing, Hypnopodi etc.

6 **Test**
Nach der Trance unterhalten A und B sich über die Testsituation.

2 Beziehung des Bewussten mit dem Unbewussten im Klienten - aus Sicht des Coach

2.1 Unbewusstsein, Vorbewusstsein und Bewusstsein

Eine wirksame Trance für alle und alle Anliegen gibt es nicht. Manche Menschen bringen eine optimale Trancefähigkeit mit - andere müssen diese erst entwickeln. Letztlich sind es die unbewussten (vor den bewussten) kognitiven und anderen Gewohnheiten, welche für die Trance-Beschaffenheit und deren Wirksamkeit entscheidend sind.

Folglich ist es einleuchtend, dass für chronische Schlaflosigkeit (oberflächlicher Schlaf) eine tiefe, volle Trance in der Regel sehr heilsam ist.

Hingegen ist genau beim Symptom Schlaflosigkeit oft auch der Weg in eine tiefe Trance blockiert. Die Hypnose eignet sich dabei als ein gutes Trainingssystem, um sowohl eine volle Trance wie auch einen vollen Schlaf zu entwickeln.

Es sind verschiedene Kombinationen von Trancebefindlichkeiten möglich. Dazu zählt auch das ‚ganz weg sein' das ‚noch deutlich hören können und sich doch schon in voller Trance sich befinden' und manchmal merkt der Klient noch nicht einmal, dass er sich bereits in Trance befindet; in einem solchen Fall fehlt es meist an der entsprechenden Körperwahrnehmung.

Um eine Lerntrance entwickeln zu können, ist eine ausgewogene Beziehung zwischen **Unbewusstsein, Vorbewusstsein** und **Bewusstsein** optimal.

3 Schmerzmanagement

3.1 Zentrales Wissen rund um den Schmerz

3.1.1 Schmerz – eine Definition

Die International Association for the Study of Pain definiert Schmerz folgendermaßen:

„Schmerz ist ein unangenehmes Sinnes- oder Gefühlserlebnis, das mit tatsächlicher oder potenzieller Gewebeschädigung einhergeht oder von betroffenen Personen so beschrieben wird, als wäre eine solche Gewebeschädigung die Ursache."

Die gleiche Schmerzeinwirkung kann von verschiedenen Personen sehr unterschiedlich wahrgenommen werden. Schmerz ist also immer auch eine subjektive Wahrnehmung, die nicht alleine von den neuronalen Signalen aus den Schmerznervenfasern an das Gehirn bestimmt wird.

Wichtig ist es zu wissen, dass Filterprozesse unseres Zentralnervensystems dafür sorgen, dass eine körperliche Schädigung nicht zwangsläufig zu Schmerz führt. Ein gutes Beispiel hierfür ist das Phänomen der Stressanalgesie. Oft wird ein akuter Schmerz durch Verletzungen während eines Kampfes, Verkehrsunfalls, Sportgeschehen gar nicht bemerkt.

Von funktionellen Schmerzen hingegen sprechen wir, wenn Schmerzen auch ohne körperliche Schädigung bestehen (z.B. Phantomschmerz). Häufig besteht hierbei eine Schädigung/Veränderung im Gehirn, womit die Schmerzquelle erklärt wird.

Zusammenfassend kann man sagen: Schmerz ist primär das, was der Patient als solchen empfindet. Das Schmerzempfinden ist stark subjektiv gefärbt.

3.1.2 Der sensomotorische Kortex

Wollen wir mit Hypnose Schmerzen beeinflussen, ist es wichtig, den sensomotorischen Kortex zu beeinflussen. Was ist dessen Funktion? Der sensomotorische Kortex «beurteilt die Signale» welche aus dem Nervensystem ins Gehirn gelangen. Er ist dafür verantwortlich zu entscheiden, mit welcher Qualität ein Signal vom Gehirn gewertet werden soll: schmerzhaft, positiv oder rein informativ. Wichtig zu wissen: Hier werden neben körperlichen Schmerzreizen auch emotionale Schmerzen verarbeitet.

Mit der Hypnose versuchen wir nun den sensomotorischen Kortex zu „lähmen“, sodass er eingehende Schmerzsignale nicht mehr interpretiert bzw. kein entsprechendes Schmerzsignal mehr weiterleitet. Wenn dies gelingt, dürfte auch kein Schmerz mehr entstehen.

Kapitel 1 bezieht sich auf das Verständnis von Jan-Henrik Günter von Thermedius. Er schreibt: «Exakt auf diesem Prinzip arbeitet ein großer Teilbereich der schmerzbefreienden Hypnose. Sie versucht, den sensomotorischen Kortex zu „manipulieren“, indem sie eine Art „Ruhegehirnwelle“ (SMR, 14 Hz) provoziert, die den sensomotorischen Kortex in seiner Aktivität einschränkt und damit dafür sorgt, dass eingehende Schmerzsignale „ungehört verpuffen“».

3.1.3 Körperlicher oder zentraler Schmerz

Wir unterscheiden zwei verschiedene Arten von Schmerz: den „körperlichen Schmerz“ und den „zentralen Schmerz“.

Unter „körperlichem Schmerz“ verstehen wir einen Schmerz, der dadurch entsteht, dass ein Reiz vom sensomotorischen Kortex verarbeitet wird und von diesem dann ein Signal zur Schmerzerzeugung weitergeleitet wird.

Der „Zentrale Schmerz“ hingegen ist ein Schmerz, welcher nicht den Weg über den sensomotorischen Kortex nimmt, sondern im Gegensatz „von innen heraus“ entsteht. Als Beispiel können wir hier die Migräne nennen, bei welcher überschüssige elektrostatische Aktivitäten im Spiel sind. Weitere Ursachen können direkte Schädigungen am Gehirn oder Nervensystem sein sowie durch chemische/biochemische Reaktionen. Der „zentrale Schmerz“ veranlasst die Schmerzreaktion im limbischen System/der Amygdala praktisch selbsttätig, ohne Zutun des sensomotorischen Kortex.

Dies kann eine Erklärung sein, weshalb gewisse Schmerzarten mit Hypnose schwerer oder manchmal gar nicht zu beeinflussen sind. Generell setzen wir mit der Hypnose am sensomotorischen Kortex an. Ist dieser nicht an der Schmerzerzeugung beteiligt, kann es sein, dass die Hypnose nur wenig Angriffspunkte hat, die die Schmerzentstehung hemmen können.

Nichtsdestotrotz: Hypnose kann oft auch durch indirekte Einwirkung zentrale Schmerzen hemmen. So hat sich z.B. der präventive Einsatz der Hypnose bei Migräne bewährt. Ein Gewinn ist es generell, die Hypnose einzusetzen, damit das ganze System des Klienten eine Entspannung und eine Reizreduktion erhält.

3.2 DEEP STATE Hypnose

Das vom Thermedius Institut entwickelte Deep State Hypnose Konzept hat sich bestens zur Schmerzreduktion bewährt. Dabei wird eine schmerzreduzierende Trance erzeugt, die vor allem eine Beruhigung des sensomotorischen Kortexts zum Ziel hat. Dort werden Schmerzreize verarbeitet und bei Bedarf ein Alarmsignal an die Amygdala/das limbische System weitergeleitet. Bleibt das System trotz eines Eintreffens eines Schmerzreizes ruhig, so entsteht auch keine Alarm- oder Abwehrreaktion und der Patient leidet somit nicht unter Schmerzen.

Durch die tiefe Trance wird es nicht nur möglich, Schmerzen abzuschalten, sondern wir erzeugen generell einen wunderbaren Zustand der Regeneration, der Selbstheilung. Unser Körper und unsere Psyche erhalten damit die Chance, neue Kräfte zu tanken. Damit lohnt sich die Anwendung auch, ohne dass Schmerzen da sind. Auch für Tinnitus Patienten hat sich diese Form der Trance bewährt.

Vorgehen / Ablauf:

1. **Kreiere einen sicheren Ort** / einen Regenerationsraum

2. Für die Schmerzabschaltung hat sich das **Erzeugen von Katalepsie** sehr bewährt. Dies kann durch Aufstellen der Hand erzeugt werden. Oder durch Einleiten einer Armlevitation (auch für Selbsthypnose). Oder man lässt den Patienten «Magnetische Finger» halluzinieren. Damit ist ein erster Impuls für Schmerzabschaltung gegeben.

3. **Rückwärtszählen**. Obwohl Rückwärtszählen von den meisten Menschen als einfach wahrgenommen wird, stellt es für den sensomotorischen Kortex eine hohe Anstrengung dar und der Patient wird dadurch motiviert in einen Ruhezustand zu gehen. Das Zählen soll langsam vor sich gehen. Zwischen jeder Zahl soll mindestens ein tiefer Atemzug genommen werden.
   «Nun bitte ich dich, sehr langsam von 400 rückwärts zu zählen. Und erstaunlicherweise wirst du mit jeder Zahl feststellen, wie es dir schwerer und schwerer fallen wird, die nächste Zahl zu finden oder sie gar auszusprechen. Und zwischen jeder Zahl nimmst du

einen tiefen angenehmen Atemzug. Mit jeder Zahl verschwinden die anderen Zahlen immer mehr und mehr aus deinem Gedächtnis… bis du immer ruhiger und entspannter bist… In einem Zustand der vollkommenen Entspannung. Die Zahlen werden immer unwichtiger.»

Der Patient soll so lange zählen bis er entweder a) bei 0 ist, b) nicht mehr weiter zählen kann, weil ihm das Sprechen schwerfällt, c) oder bis er 5 Minuten gezählt hat. Ihr könnt den Patienten auch bei 1000 beginnen lassen und in 3er Schritten rückwärts zählen lassen (1000, 997, 994,…)

4. **Körperfokussierung:** Jetzt lasst ihr den Patienten – ohne, dass er dabei etwas verändert oder verändern will – verschiedene Stellen seines Körpers fokussieren.

   «Ich will, dass du jetzt deine ganze Aufmerksamkeit auf deinen linken grossen Zehen fokussierst, … ((Pause))
   deine rechte Schulter, … ((Pause))
   dein linkes Knie, … du darfst alles fühlen, was du fühlen kannst … ohne etwas zu verändern …»

   Du kannst die verschiedenen Körperstellen frei auswählen. Wichtig: Es muss immer wischen links/rechts sowie unten/oben wechseln. Was löst das aus? Diese verschiedenen Wechsel werden vom sensomotorischen Kortex als starke Irritation wahrgenommen und veranlassen ihn, in einen Ruhezustand überzugehen.

5. **Sicherer Ort / Regenerationsort**: Nun lädst du deinen Patienten ein, sich an den zuvor definierten bzw. erzeugten sicheren Ort zu begeben. Dabei soll er sich so intensiv wie nur möglich in diese Vorstellung hineinversetzen.

   Diese Situation soll sehr angenehm sein und am besten mit einer Aktivität verbunden sein (z.B. Wandern, Spazieren, Schwimmen, Velo fahren etc.). Dadurch, dass der Patient sich möglichst intensiv in die angenehme Situation hineinversetzt, wird eine Dissoziation erzeugt. Hierdurch erzeugt man auch den Effekt, dass das Gehirn glaubt, dass allfällige Schmerzreize Traumwahrnehmungen sind, die keine reale Reaktion nötig machen. Man kann von einer künstlichen REM-Blockade sprechen.

   Man gibt die Suggestion, dass er die Konzentration auf den sicheren Ort und die Aktivität erhöht werden soll, wenn etwas Störendes im Aussen stattfindet.

6. **Test**

ABLAUF

• Induktion:	
○ Katalepsie / Armlevitation / Magnetische Finger	2 Minuten
○ Augen schliessen lassen, Pause	1 Minute
○ Langsames Rückwärtszahlen (Start bei 400) in 3er Schritten (oder bis der Patient aufhört zu zählen)	5 Minuten
○ Pause, Gehirn zur Ruhe kommen lassen	1 Minute
○ Körperfokussierung (links/rechts unten/oben abwechseln)	10 Minuten
○ Pause	1 Minute
• Aufforderung an sicheren Ort gehen (VAKOG). Zeit lassen für Umstellung auf «künstlichen Traummodus»	3 Minuten
• Test des Deep-States ○ Katatonie: Heben eines Armes. Bleibt er stehen? ○ Aufforderung Bein zu heben ○ Aufforderung Augen zu öffnen ○ Analgetischer Test, Kneifen	
• Langsame und direktive Ausleitung mit Zählen von 1 bis 10. Danach Erfahrung besprechen.	

Die Dauer der Induktion liegt bei ca. 23 Minuten.

Danach kannst du deinen Klienten 40-45 Minuten im Deep-State lassen (bei chronischen Schmerzen, Tinnitus). Hier machst du keinen Schmerztest mehr. Der Schmerztest wird vor allem eingesetzt, wenn als Vorbereitung auf eine Operation eine Hypnotische Analgesie entwickelt werden soll und wir im Vorfeld überprüfen, ob die Hypnotische Analgesie wirksam ist.

Der ganze Vorgang kann bis 1 Stunde dauern, wenn du deinen Patienten an seinem sicheren Ort bzw. Regenerationsort lässt, damit sich sein Körper und seine Psyche regenerieren kann.

Bezüglich des Tests: Wichtig ist nicht, wie weit der Patient mit Zählen gekommen ist, oder ob er z.B. das Bein heben kann etc. Wichtig ist nur: Hat der Patient den Schmerzreiz wahrgenommen oder nicht? Und wenn ja, wie hat er den Reiz wahrgenommen?

Wichtig: Sei sparsam mit Suggestionen. Lass lange und sehr lange Pausen entstehen, in denen du als Hypnotherapeutin nichts sagst, sodass der Patient in seinem eigenen sicheren Ort bzw. Regenerationsort sein kann und alle Aussenreize abschirmt.

Wiederholung kann ein wichtiger Erfolgsfaktor sein. Erwarte nicht, dass dein Patient alles schon beim ersten Durchgang kann. Gib ihm Anleitung zur Selbsthypnose.

3.3 Hypnotische Phänomene im Schmerzmanagement

Hypnose ist gut geeignet, um Schmerzen zu reduzieren oder gar zu eliminieren. Hypnose kann in bestimmten Fällen sogar als einziges oder hauptsächliches Anästhetikum für Operationen verwendet werden.

In Anwendung der hypnotischen Phänomene beim Schmerzmanagement wird die Möglichkeit des Klienten (und unsere) geprüft, **Analgesie, Anästhesie, Amnesie, partielle Dissoziation, totale Dissoziation, zeitliche Reorientierung, positives Halluzinieren sowie Empfindungsverzerrungen** einsetzen zu können.

➔ **Bei Schmerz ist es oft angezeigt vorab eine medizinische Abklärung vorzunehmen!**

Nachfolgend einige symptombezogene Strategien, die direkt am Schmerzerleben ansetzen:

3.3.1 Analgesie

Darunter versteht man das Verschwinden des Schmerzes. Im selben Körperbereich ist man jedoch noch fähig andere Empfindungen wahrzunehmen.

Beispiel: Es wird ein **schmerzunverträgliches Gefühl suggeriert** wie **Kühle, Kribbeln, Taubheit, Wärme, Leichtigkeit und Schwere**. Das Vorgehen besteht darin, dass man zuerst in einem schmerzfreien Bereich des Körpers die betreffende Empfindung induziert und diese sich folgend in den Schmerzbereich ausbreiten oder übertragen lässt.

3.3.2 Anästhesie

Fehlen von Empfindung. Vorgehen gleich wie bei Analgesie.

3.3.3 Amnesie

Das nicht erinnern können. Die **Nutzung von Amnesie** ist vor allem dann angezeigt, wenn der **Schmerz in Attacken** auftritt und die Person in den schmerzfreien Perioden **Erwartungsängste** verfolgen. Mit der Amnesie wird dann jeder Anfall **wie neu** erlebt.

3.3.4 Partielle Dissoziation

Die Induktion der Losgelöstheit vom eigenen Körper kann Linderung verschaffen. Je nach Sitz des Schmerzes können auch weitere hypnotische Phänomene genutzt werden.

Beispiel: Bei Sitz des Schmerzes im Arm kann die Armlevitation oder Katalepsie verwendet und mit entsprechenden Suggestionen gekoppelt werden, z.B. indem **suggeriert** wird, dass in **Trance** der **schmerzende Arm** vom **Körper getrennt** ist und **beim wieder Ankoppeln** des Armes der **Schmerz draussen** bleibt.

3.3.5 Totale Dissoziation

Mit entsprechenden Mitteln – z.B. sich über innere Bilder weg **visualisieren** und fühlen - **sich Selbst vom realen Körper lösen**. Diese Anwendung ist besonders bei terminal kranken Menschen geeignet. Liegend.

3.3.6 Zeitliche Re-Orientierung

Die Person wird dabei **zurück** in die **Vergangenheit** oder **vorwärts** in die **Zukunft,** in **einen schmerzfreien**, **emotional positiv** besetzten **Lebensabschnitt versetzt**.

3.3.7 Halluzinieren (kinästhetisch)

Ein **Schmerzgefühl** wird **innerhalb** des Körpers - oder aus dem Körper hinaus - **verschoben** oder **gedreht**. Dabei kann man den Schmerz u.a. punktförmig werden oder sich verteilen lassen.

Eine sehr unangenehme Schmerzqualität wird dabei durch eine andere, anfänglich auch unangenehme aber besser verträgliche, ersetzt.

Beispiel: Ein hämmernder Schmerz wird durch einen leise pochenden Schmerz ersetzt. Nach einer Intervention ist jeweils der Effekt zu prüfen.

3.4 Übung 3: Analgesie

1 Anwendungsbereich eruieren, z.B. Zahnarzt (Spritze, Bohren), Arthrose Schmerzen etc.

2 Eine Stelle der Hand schmerzfrei machen, andere Empfindungen sind o.k. Dazu Suggestionen der Taubheit (eingeschlafene Hand) oder an die Wirkung von Novocain erinnern etc.

3 In Trance testen (Nadel!).

4 Analgesie an den Zielort im Körper transferieren, hinleiten.

5 Posthypnotische Suggestion.

6 Abschluss & Feedback.

3.5 Komplexe Ansätze im Schmerzmanagement

3.5.1 Umdeutung

Der Schmerz wird mit weniger negativen Inhalten verknüpft.

Beispiel: Ein stechender Schmerz wird mit barfuss gehen auf steinigem Meeresstrand assoziiert.

3.5.2 Symbolische Transformation

Sehr geeignet Submodalitäten anzuwenden.

Der Schmerz wird symbolisch in einem oder mehreren Bilder(n) repräsentiert. Mit Veränderung der Bilder verändert sich auch der Schmerz.

Beispiel auf einfachste Art und Weise: Bei Schmerz wird suggeriert sich einen Schalter vorzustellen, welcher auf ‚on' steht um ihn dann auf ‚off' schalten! (Visualisierung)

3.5.3 Schmerzbezogene Metaphern

Ohne notwendigerweise eine oder mehrere der hier angebotenen Strategien in einer Geschichte zu verwenden, kann bspw. auch erzählt werden, wie es jemandem in seinem normalen Alltag gelungen ist seinen Schmerz oft zu vergessen.

3.5.4 Einstreutechnik

Es werden, meiste im Verlauf langer Geschichten oder Monologe welche durchaus thematisch alltägliche und geläufige Aspekte der Person aufgreifen können, laufend Suggestivwörter eingestreut, welche letztlich die Aufmerksamkeit zu anderen Gefühlen hinlenken (oft verwendet bei terminal Kranken).

3.6 Schmerzmanagement mit Hypnose

Wir unterscheiden an dieser Stelle vor allem zwischen **organisch** bedingtem und **psychogenem Schmerz**. Bei organischen Schmerzen handelt es sich um reine **Schadensmeldungen** die via Nozirezeptoren (Haut- und Körpereigene-Rezeptoren) und Rückenmark dem **Gehirn** zugeleitet werden (Schmerz entsteht im Gehirn).

Schmerz ist jedoch immer auch **subjektiv**, individuell geprägt. Das bedeutet, dass Schmerz durch die Interpretation des Gehirns mit verursacht wird. Dabei existiert auch eine körpereigene Schmerzhemmung (Gate-Control-Theorie).

Viele Formen des Schmerzes sind nicht mit einer primären bzw. physischen Ursache verbunden. Dies da Neuronale Netzwerke in Rückenmark und Gehirn (neuronale Plastizität) mitmischen. Auch auf molekularer Ebene, z.B. über Proteinstrukturen von Nervenzellen, kann eine Schmerzüberempfindlichkeit verursacht werden (Schmerzgedächtnis).

Auch kann gegenwärtiger oder vergangener Stress in der Gegenwart mit der Schmerzentstehung wie auch Schmerzaufrechterhaltung und Schmerzintensivierung in Zusammenhang gebracht werden.

Beispiel: Wenn man am Ellbogen bereits schon einmal denselben Schmerz gespürt hat, ist es gut möglich, dass der gleiche Schmerz beim nächsten Mal intensiver empfunden wird.

Bei Schmerzthemen ist es deshalb meist angezeigt, den Sekundärgewinn bzw. eine mögliche, positive Absicht im Schmerzgeschehen, zu erkennen und in die Behandlung einzubeziehen. Dies, weil verschiedene, vorgängige Erlebnisse, Einstellungen und Verhaltensweisen können den Schmerz (mit-)bedingen.

Da es in diesem Modul vorwiegend um das Kennenlernen der **hypnotischen Methodik** zur **Veränderung** der **Schmerzdynamik** geht, handeln wir das mögliche Vorhandensein einer ursächlichen Gegebenheit hier nur kurz ab.

Eine mögliche, noch aktive Ursachendynamik wird derart miteinbezogen, dass bei den Versuchspersonen, bei welchen ein bewusstes Commitment zum konstruktiven Umgang mit der positiven Absicht des Schmerzes möglich ist, dieses Commitment auch bewusst eingefordert wird.

Bei den Versuchspersonen, bei welchen es hingegen nicht angebracht scheint, offen über den Schmerzhintergrund zu sprechen, wird die Erkenntnis oder Vermutung der positiven Absicht ausschliesslich **indirekt** als Botschaft in das Unbewusstsein mit eingeflochten.

➔ Das Integrieren der positiven Absicht in den hypnotischen Ansatz wird an anderer Stelle des Trainings vermittelt.

Wichtig bei Schmerz: Kontrollüberzeugung!

4 Sprachmuster der hypnotischen Kommunikation II

4.1 Die wichtigsten Sprachmuster

4.1.1 Verneinungen (verneinte Befehle)

…möglicherweise ist es gar nicht gut, wenn sich gewisse Leute zu früh wohl fühlen.

4.1.2 Frage am Ende des Satzes (Tag Questions)

…du hast doch jetzt gerade erlebt, dass dein UBW mit dir kooperiert, nicht wahr?

…ich verstehe, du kannst es nicht. Du kannst es, nicht (?).

4.1.3 Stopp

…du hast diesen Gedanken so viele Male durchgedacht, so dass …….STOPP und spüre doch anstelle dieses Gedankens nun das Gefühl deines Tigerseins, welches nun damit beginnt dich ganz und gar zu durchströmen…

4.1.4 Verkettung von modalen Operatoren

…ich höre schon, dass du glaubst es nicht tun zu können..... allerdings, wenn..... wir es genau überdenken, musst du es vielleicht auch gar nicht, denn..... wenn du es tun solltest, ohne es wirklich zu wollen, dann..... kannst du es vielleicht auch gar nicht, weil du dir möglicherweise..... noch nie wirklich erlaubt hast .....es zu tun dürfen zu müssen, da du ev. nicht weißt, dass ..... du es auch einfach dürfen könntest, um damit..... nun wirklich jetzt zu beginnen es einfach zu tun.

4.1.5 Versuche vergeblich (zu verhindern)

...so stark du vergeblich versuchen kannst nochmals die alten Gefühle zu erleben, behältst du nun den ständigen Kontakt mit den angenehmen, weich fliessenden Emotionen, die dir die Sicherheit vermitteln, welche du in dieser Phase deines Lebens vielleicht wirklich mehr als alles andere so richtig brauchst.

4.1.6 Den Namen aussprechen

...die meisten Menschen finden es ganz natürlich, dass man sich in Trance, Alice, entspannen kann, weil...

4.1.7 Mehrdeutigkeiten

- Mehrdeutigkeit des Satzbezuges:

...und während ich zu dir als Kind spreche...

...so dass es dir leicht fallen wird die Augen zu schliessen und in eine tiefe Trance zu fallen.

…dieser Mensch hat mich (sehr) berührt.

- Syntaktische Mehrdeutigkeit:

…es gibt unendlich viele Möglichkeiten, sie (Sie) warten auf Sie (sie).

…Haustiere können sich so gut entspannen; können (sie) Sie es wirklich?

…,ich kann es nicht!' - 'O.K., ich verstehe; Du kannst es,.....nicht (?)' (nicht wahr).

4.1.8 Worte welche Vorannahmen verstecken - Magische Worte, welche Akzeptanz bewirken

Das **Verwenden dieser** Wörter, was übrigens dem natürlichen Sprachgebrauch entspricht **bewirkt**, dass die **Kernaussage** des **Satzes weniger** bewusst oder **kritisch wahrgenommen** oder hinterfragt wird. **Vorannahmen** können so den **Status** der **Realität** oder **Wahrheit** erhalten. Folgen verschiedene Beispiele dazu:

a) Oder

Oder impliziert eine Wahl - oder kann auch **bewusst eingesetzt** werden um die **Illusion** einer **Wahl** zu erwirken.

Beispiele:
- Ich weiss nicht, ob sie eher in eine leichte Trance **ODER** tiefe Trance gehen werden.
- Als Verkäufer fragen sie nicht: Wann kann ich Sie anrufen?
  -> Sondern: Kann ich Sie besser am Morgen **ODER** Nachmittag erreichen?

b) Zeitwörter

Zwei **Ereignisse** werden als **zeitliche Abfolge** dargestellt. Dadurch **entsteht** der **Eindruck** der **Plausibilität** der **Aussagen**. Zeitwörter: **Bevor, wenn, sobald, während, nachdem, seit etc.**

Beispiele:
- **Während** sie bewusst noch die eine oder andere Option abwägen, kann ihr Unbewusstsein bereits eine Wahl getroffen haben.
- Bitte putze deine Zähne nicht **eher**, als du dein Stück Schokolade gegessen hast.

c) W-Fragen

Beispiele:
- Wie tief werden sie wohl heute in Trance gehen?
- Wann wird sich heute ihr Unbewusstsein mit einem Fingersignal melden?

d) Kommentierende Adjektive und Adverbien

Adjektive und Adverbien:

Interessanterweise, erfreulich, schade, hoffnungsvoll, seltsamerweise etc.

Beispiele:

- Interessanterweise vertieft sich nun deine Trance um alsbald mit einem Finger der rechten oder linken Hand zu zucken?!
- Erfreulicherweise findest du jedes Mal schneller in Trance sodass sich die Veränderung noch nachhaltiger in deinem Leben ausbreiten kann.

4.2 Bindungen und Doppelbindungen

4.2.1 Bindungen

Bindungen bieten eine freie Wahl von zwei oder mehr vergleichbaren Alternativen. Das bedeutet, dass welche Wahl auch immer getroffen wird, es trotzdem immer in die gewünschte Richtung geht.

Therapeutische Bindungen sind taktvolle Angebote möglicher, alternativer Formen konstruktiven Verhaltens, welche für den Klienten in einer gegebenen Situation **neu** verfügbar sind. Dem **Klienten** wird eine **freie**, beliebige **Wahl zwischen** den **verschiedenen Angeboten** gegeben. Gewöhnlich fühlt sich der Klient jedoch verpflichtet, eine der Alternativen zu wählen.

Beispiele:

- Möchtest du langsam oder schnell in eine Trance gehen?
- Möchtest du liegend oder sitzend in Trance gehen?

4.2.2 Doppelbindungen

Doppelbindungen bieten **Verhaltensmöglichkeiten**, welche **ausserhalb** der **gewöhnlichen Reichweite** der **bewussten Wahl** und Kontrolle des **Klienten** stehen. Was eine Bindung oder Doppelbindung ist hängt davon ab, wie die Botschaft vom Zuhörer empfangen wird. Letztlich entscheidet der Klient, was eine Bindung oder Doppelbindung ist.

Beispiel:

- Wird sich zuerst deine linke Hand oder deine rechte Hand anfangen sich leicht zu fühlen? Oder werden sie beide zur gleichen Zeit diese Leichtigkeit fühlen?

4.2.3 Zeit und Doppelbindung

Zeit und Doppelbindungen verbinden Zeit mit einer autonomen Reaktion des UBW.

Beispiel:

- Wird deine Hand schon jetzt oder in ein paar Minuten wärmer oder kälter werden?

4.2.4 BW / UBW und Doppelbindung

Beispiel:

- Wenn dein UBW will, dass du in Trance gehst, wird sich deine rechte Hand heben - sonst wird sich deine linke Hand heben.

4.2.5 Doppel-Dissoziations-Doppelbindung

Du kannst als **du** erwachen, aber du brauchst nicht als **Körper** zu erwachen.....Du kannst erwachen, wenn dein Körper aufwacht, aber ohne ihn zu erkennen (beachten).

Beachte folgend die Bindungen und Doppelbindungen:

Kannst du dich bequem hinsetzen und deine Hände leicht auf deine Schenkel legen (wie es der Therapeut vorzeigt)? So ist es recht, ohne dass sie sich gegenseitig berühren.

Kannst du auch deine Hände ganz leicht auflegen, so dass die Fingerspitzen kaum deine Schenkel berühren?

So ist es recht. Jetzt, wo sie so leicht daliegen, bemerkst du, wie die Fingerspitzen tendieren, sich mit jedem Atemzug ein bisschen von selbst zu heben?

Beginnen sie sich noch leichter und müheloser von selbst zu heben, je mehr sich dein Körper entspannt?

Während dem du dich weiter entspannst, hebt sich jetzt die eine oder andere Hand stärker oder vielleicht beide gleichzeitig?

Und bleibt diese Hand oben und steigt sie allmählich ganz von selbst immer höher? Will ihr die andere Hand folgen oder will sie sich in deinem Schoss entspannen?

Gut so. Und hebt sich diese Hand weiter mit diesen kleinen zuckenden Bewegungen, oder hebt sie sich immer ruhiger, je mehr und mehr sie sich dem Gesicht nähert?

Bewegt sie sich rascher oder langsamer, während sie sich mit zunehmendem Wohlbefinden deinem Gesicht nähert? Braucht sie eine kleine Pause, bevor sie schliesslich dein Gesicht berührt, damit du weißt, dass du in eine Trance übergehst? Und sie wird dein Gesicht nicht berühren, bis dein Unbewusstes wirklich bereit ist, dich tiefer gehen zu lassen, nicht wahr?

Und wird dein Körper automatisch einen tieferen Atemzug machen, wenn deine Hand dein Gesicht berührt, während du wirklich entspannen und erleben kannst, wie du tiefer gehst?

So ist es gut. Und wirst du überhaupt das zunehmende Gefühl des Wohlbefindens bemerken, wenn deine Hand langsam ganz von selbst in deinen Schoss zurückkehrt? Und wird dein Unbewusstes schon träumen, wenn deine Hand zur Ruhe kommt?

5 Mit Hypnose und High Quality Information zu Lösungen in Trance

5.1 High Quality Information

Wie aus den vorangegangenen Kapiteln klar hervorgeht, ist es für den erfolgreichen Veränderungsprozess oft entscheidend, wesentliche Informationen über den Klienten zu kennen und verfügbar zu haben. Dazu zählen auch allgemeine Informationen, welche häufig für die Veränderungsarbeit unerlässlich sind.

Zusammen gefasst handelt es sich dabei um **Aspekte** der **Haltung**, des **Verhaltens**, der **Kognition** und der **psychischen** sowie der **physischen Konstellation** (Metabolismus usw.), welche in der Regel auf ein **spezifisches Problem** oder **Symptom zutreffen**.

Kurz: Es ist hilfreich, um nicht zu sagen **essentiell**, dass **spezifische Informationen** zur **Behandlung** von Depression, Übergewicht, Alkoholismus, Krebs, Morbus Basedow, Rauchen, Trauma, Phobien sowie Prüfungsangst vorliegen und **verfügbar sind**.

In diesem Teil des Skriptes werden diese **High Quality Information ausdrücklich** mit **einbezogen. Entsprechend** sind auch die **Themen ausgewählt**. Dabei geht es um die berühmten **‚Unterschiede, die Unterschiede machen‘** (systemische Theorie und Praxis).

Für die **Kursteilnehmer** welche **beruflich** mit **Hypnose arbeiten** (werden) gilt deshalb:
1. Literatur beiziehen (z.B. Revenstorf, Peter; Hypnose in....; Springer) und sich so und/oder
2. In weiteren Trainings die entsprechenden Informationen zu besorgen sowie das Können anzueignen.

5.2 Wie magisch ist Hypnose?

Einige Gedanken zu Magie in der Hypnose

Oft wird magisches Denken als primitiv in dem Sinne angesehen, dass es sich dabei nur um eine Entwicklungsphase in der Mensch- und Kindheit gehandelt hatte. Bei dieser Art des **magischen Denkens** werden verschiedene **Gegebenheiten** (Situationen, Erleben, Sachen, Emotionen) miteinander in einen **zwingenden Zusammenhang** gebracht (verbunden), ohne dass sich dieser Zusammenhang wirklich funktionell beweisen lässt. Ein Beispiel dafür ist, dass tragischer Weise, für das Nashorn, glauben viele Chinesen an die magische Wirkung seines Hornes.

Doch gerade mit der Trance und Hypnose können wir diese ‚magische Veranlagung' nutzen um Beziehungen zwischen Dingen (geistig oder konkret) herzustellen, welche Veränderungen bewirken. Unter ‚magischer Veranlagung' verstehen wir das, was der einzelne Mensch (Klient) an magischen Bezügen mitbringt.

Je weniger die Arbeitsweise des HypnoCoach oder der Hypnotherapeutin durchschaut wird, umso magischer und mystischer kann die hypnotische Veränderungsarbeit auf eine Klientin oder einen Aussenstehenden wirken.

Letztlich aber erlaubt uns die Trance als therapeutischer Rahmen vor allem bewusste und/oder unbewusste Einstellungen zu ändern und mit aktiver Hilfe des Klienten neue zu besetzten.

Viele Menschen kommen mit der Einstellung zur Hypnose, dass die diese ihr Problem magisch und ohne ihre aktive Mithilfe löst, gewissermassen remedial. Für den HypnoCoach ist es deshalb wichtig, die Einstellungen der Klientin zu erkennen und entsprechend in die Veränderungsarbeit einzubeziehen. Besonders bei sogenannten Verhaltensstörungen (Übergewicht, Rauchen, Alkoholmissbrauch, Nägel beissen etc.), ist die aktive Mithilfe der Klienten gefordert.

Natürlich gibt es auch hypnotisches Veränderungsgeschehen, wie bspw. bei lebensbedrohlichen Krankheiten, bei denen der Glaube an die Trance und die Kompetenz des HypnoCoaches

überraschende Heilung bewirken kann. Denn dank diesem Glauben kann im Klienten die Entstehung eines neuen Selbstbildes sowie der ausgewogenen Kontakt zum UBW, bzw. zu den Systemen des Körpers (z.B. Immunsystem) in sehr kurzer Zeit und effektiv hergestellt werden. Da bei diesen wichtigen Prozessen bislang noch wenig verstandene und sehr komplexe Aspekte im Spiel sind, wirken die Resultate umso magischer auf uns.

So bleibt doch die Einsicht bestehen, dass wirksame Hypnotherapie davon abhängt, wie der HypnoCoach seine Anregungen (Ideen, Verständnis, Suggestionen) der hypnotisierten Person vermittelt. Es müssen die Bedürfnisse, der Lernstiel, Erfahrungen und Ressourcen so kommuniziert werden, dass die Person die Suggestionen für Veränderung akzeptieren und umsetzten kann.

5.3 Symbolisches und metaphorisches Denken

In der Alltagssprache geäusserte Metaphern können wichtige High Quality Information beinhalten. Und da das metaphorische Denken eine natürliche Aktivität darstellt, welche wir automatisch tätigen, brauchen wir unserem Gegenüber bloss zuzuhören, um zu diesen Informationen zu gelangen.

Am besten kennen wir symbolisches Denken aus dem übertragenen Sinn, bspw.:
Du machst aus jeder Mücke einen Elefanten.
Oft ist es auch der wesentliche Aspekt eines Witzes: Zwei Jäger trafen sich. - Beide tot.

Da wir die Metaphorik in der Hypnose einsetzen lohnt es sich zu wissen, dass Menschen dafür einen Sinn haben. Doch die Fähigkeit Gebrauch von Metaphorik zu machen, kann sehr verschieden sein.

Dass das metaphorische Denken ein natürlicher innerer Vorgang ist, wurde schon lange erkannt. Metaphern bestimmen unser Denken und Handeln durch die Wahrnehmung, das Verstehen, Entscheiden usw. Sie wirken wie innere Wegweiser, indem sie Erfahrungen und anderes neuronales ‚Material' zusammenfassen und auf den Punkt bringen können.

Wenn wir die metaphorische Sprache eines Klienten beachten, erhalten wir oft den Schlüssel dafür zugespielt, um was es bei einem Thema (auch noch) geht. Beispielsweise kann jemand sagen, ‚es sitzt mir was auf.' Nehmen wir diese Aussage wörtlich und fragen nach, taucht nicht selten eine Mutter oder Vater auf, die mit dieser Belastung verbunden ist (weitere Mikro-Metaphern, siehe Seite 41).

Wie schon im Hypno 1 Training vermittelt, erweitern wir Aussagen ins metaphorische, indem wir bspw. bei einer Aussage eines Klienten fragen: ‚Wie wer oder was?' Darauf kommt oft eine Antwort, welche ein Symbol oder eine Metapher enthält.

Ebenso können wir Aussagen in 3D-Metaphern erweitern. Wenn ein Klient von seiner Angst spricht, können wir ihn auffordern diese Angst vor sich im Raum zu sehen. Dies kann der Beginn sein, neue Einsichten auf oder Distanz zur Angst zu gewinnen oder die Angst sogar, wie in den nachfolgenden Übungen aufgezeigt wird, zu integrieren.

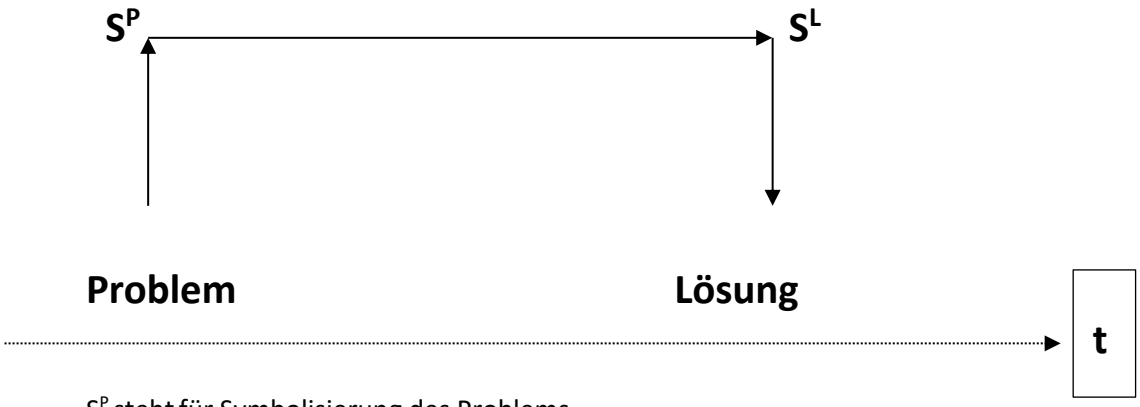
5.3.1 Konkret oder symbolisch

Um zu verstehen, Richtung zu geben, einzuordnen, zusammenzufassen sowie ‚Geistiges' zusammenzuhalten, gebrauchen wir natürlich und unbewusst symbolisches, metaphorisches und imaginatives Denken.

Dieses Denken können wir nun auch bewusst nutzen. Denn bei Schmerz und Angst, aber auch bei Angst/Schmerz oder in Kombination mit anderen somatischen Symptomen sowie bei Blockaden denken wir generell zu eng.

Oft haben sich im Verlaufe der Zeit neuronale Netzwerke im Gedächtnis gebildet, welche das eigentliche Problem darstellen. Mit der Erweiterung ins Symbolische wechseln wir die Ebene, lenken um und regen so zu neuen, inneren Verknüpfungen im Neuronalen wie auch generell im Unbewussten an. Dies führt häufig direkt oder sukzessive zu Lösungen. Dabei sind vermutlich laterale Suchprozesse und Ergänzungsdenken aktiv (rechte Hemisphäre), auf diesem Wege wird die Gesamtheit aller inneren Ressourcen zur Lösungsfindung aktiviert.

Damit der HypnoCoach in der Hypnose generell, wie auch speziell im Schmerzmanagement, Analogien und Metaphern anwenden kann, ist es hilfreich sich im symbolischen Denken und Handeln zu üben.



S^P steht für Symbolisierung des Problems
S^L steht für Lösung in symbolisierter Form

5.4 Übung 5: Symbolische Transformationen

1 Person A identifiziert ein sich hartnäckig Aufrecht erhaltenes Problem (P), welches ihn vor der Erreichung eines Zieles abhält oder jeweils dessen Erreichung erschwert. Keine Phobie oder zu starkes Trauma.

2 A beachtet dabei auch das dazu gehörige Gefühl. B hilft A eine symbolische bzw. metaphorische Entsprechung (SP) auf der Basis des Problemgefühls zu finden.
Wie ist es für dich? Wie, was oder wer?

3 B hilft A dabei eine symbolische Lösungsentsprechung (SL) finden.

4 A und B denken sich einen Übergang von SP nach SL aus.

5 B führt A in eine leichte Trance und geht den ganzen Vorgang mit A durch.

6 A denkt nun an sein ursprüngliches Problem und spürt nach, wie sich seine Reaktion und seine Gefühle dazu verändert haben.

7 A denkt sich nun mit dem Gefühl von 6) in die Zukunft, in der er nun seine entsprechenden Ziele einfach angehen und erreichen kann.

5.5 Mikrometaphern

Aussage Klient	Bedeutung für Klient	Frage
Ihre Worte liegen ihm schwer auf dem Magen	Worte sind Objekte mit Gewicht	Wie z.B. grosse Steine?
Dieses Erlebnis hat sie zerbrochen	Die Seele ist ein zerbrechliches Objekt	Und wenn ihre Seele dehnbar wäre?
Vom Denken rauchen uns die Köpfe	Der Geist ist eine Maschine	Hilft es, wenn ihr die Zahnräder langsamer laufen lässt?
Unsere Anstrengungen haben schlussendlich Früchte getragen	Anstrengungen sind Pflanzen	Äpfel oder Kirschen?
Der Stau kostete mich drei Stunden	Zeit ist Geld (eine begrenzte Ressource)	Wieviel kostet eine Panne?
Seine Augen heften sich an ihr Gesicht	Sehen ist berühren	Können seine Augen auch bloss sehen?
Ihre Augen wanderten ununterbrochen über jeden Gegenstand im Zimmer	Augen sind Extremitäten	Mit Wanderschuhen?
Er ist völlig verrückt nach ihr	Liebe ist Verrücktheit	Wie verrückt?
Es ist ein langer, steiniger Weg gewesen	Die Beziehung ist eine Reise	Was hat euch gehindert auf einem weichen Waldboden zu wandern?
Ich habe alle Trümpfe in der Hand	Das Leben ist ein Glücksspiel	Wirst du auf diese Hand ständig aufpassen müssen
Seine Argumentation fiel in sich zusammen	Argumente sind Gebäude	Lag es am Fundament?
Er machte alle seine Argumente nieder	Argumentieren ist Krieg	Es werden wohl keine Gefangene gemacht?
Mein Leben ist angefüllt mit Aktivitäten	Das Leben ist ein Gefäss.	Wieviel Platz bleibt übrig?
Sie fiel in eine tiefe Depression	Die Depression ist ein Gefäss	Frage: Weiss sie wie wieder herausfinden?
Die Zeit fliegt dahin	Die Zeit ist ein bewegliches Objekt	Wie genau fliegt sie?
Ich habe ihn im Auge	Das Blickfeld ist ein Gefäss	Behältst du ihn nun dort?
Das Leben hat mich betrogen	Das Leben ist eine Person und ein Betrüger	Muss es dafür ins Gefängnis?
Die Prüfung sitzt mir schwer auf	Die Prüfung ist ein schweres Objekt	Wo sitzt sie genau?
Die Prüfung ist unüberwindlich	Die Prüfung ist ein Berg	Muss sie ein Berg sein?
Die Entwicklung zeigt nach oben	Gut ist oben – schlecht ist unten	Ab wieviel oben ist gut?
Er ist auf der Höhe seines Verstandes	Verstand ist oben – Gefühl ist unten	Ist er auch wirklich schwindelfrei?
Sie versank in tiefen Schlaf	Wach sein ist oben – Schlafen ist unten	Schläft sie bei jedem Sinken?
Es gelang mir, ihm meinen Gedanken rüberzubringen	Gedanken sind Objekte	Bist du dabei gerannt?
Deine Worte wirken hohl	Worte sind Gefässe	Sind deine gefüllt?

6 Konversationelle Hypnose in der E-Mail-Kommunikation

Auch die E-Mail-Kommunikation kann ganz natürlich genutzt werden, um hypnotisch suggestiv zu kommunizieren.

Besonders dann, wenn ein Klient unter Druck steht und dringend auf Hilfe angewiesen ist, wird das E-Mail in der Regel nicht kritisch auf wohlgeformte oder logische Sprache und Grammatik analysiert, sondern es wird auf Aussagen konzentriert, welche das Leiden erleichtern und Zuversicht geben.

6.1 Übung 7: Hypno-E-Mailing

1 A und B lesen die folgenden Beispiel-Hypno-Emails durch und analysieren dabei die Sprachmuster und Suggestionen.

2 A und B konstruieren je eine schriftliche Anfrage und tauschen diese gegenseitig aus.

3 A und B formulieren je eine schriftliche Antwort und überlegen sich dabei folgende Punkte:
- Auf was - und wie - wollen sie antworten
- Sie achten darauf, dass sie in ihrer Antwort gelernte Sprachmuster **bedienen**, dies mit speziellem Einbezug von: **Befehlen** bzw. **nachhaltiger Sprache welche** in den **Text,** besondere jeweils am Ende von Abschnitten, **eingebettet** werden.
  Dann lesen sie sich gegenseitig ihre Antworten vor.

4 A und B lassen die Antworten einwirken und geben einander Feedback.

Wichtig: Der untenstehende Inhalt ist Vertraulich und ausschliesslich zum Üben im Hypno 2 bestimmt!

Beispiel E-Mails

Beispiel 1:

Lieber Herr Zulauf,

Vielen Dank für den Zwischentermin!
Im Moment geht es bei mir gefühlsmässig Berg auf und Berg ab. Auf der einen Seite schäme ich mich, auf der anderen habe ich grosse Angst.

Ich kann im Moment fast nichts essen, jeder Biss ist ein Zwang, ich habe fast permanent ein drückendes Gefühl im Magen.
Ich habe meine Freundin mit einem Mann betrogen, und obwohl alles Safe war und meine Freundin wundervoll reagiert hat, als ich es ihr gebeichtet habe, fühle ich mich total schlecht.
Ich habe Todesangst, obwohl ich vom Kopf aus weiss, dass dies wahrscheinlich unbegründet ist.
In jeder freien Minute holen mich die Gedanken wieder ein, und ich komme einfach nicht klar damit.
Es kam mir vor als hätte mich ein Teil von mir dazu ‚überredet' und ich verstehe nicht, wie ich so etwas tun konnte.

Bitte geben sie mir einen Rat wie ich damit besser klarkommen kann, ich fühle mich so schlecht.
Es tut mir leid dass ich damit nicht mehr warten konnte bis am Freitag.

Danke XY

Antwort

Lieber Herr XY

Es scheint als wenn da eine grosse Strenge Sie in der Knute hätte. Wie wenn Sie nicht das Recht hätten, ein paar grundsätzliche Erfahrungen in Ihrem Leben zu machen.

Umso mehr als Ihre Freundin sehr viel Toleranz und Grosszügigkeit gezeigt hat. Sie ist es ja, die Sie hätten verlieren können. So wäre es schön, wenn Sie sich weiter beruhigen, um sich so sich mehr und mehr in einiger Ruhe zu orientieren, was in dieser Phase Ihres Lebens echt wichtig ist. Und was echt zählt. Eben wie z.B. das zu Ihnen halten Ihrer Freundin.

So hoffe ich, dass der innere Tumult nachlässt und Sie aus dem Vorfall hervorgehen als der XY (Name), der ein Stück weiter weiss und fühlt, wer er ist und was er will.

Bis Freitag & herzlich, Erich Zulauf

Antwort

Lieber Herr Zulauf,

Vielen Dank für ihre Antwort.

Ich weiss nicht genau wie aber ihre Worte haben mir wirklich geholfen, und mich wieder etwas auf den Boden gebracht.

Und sie haben Recht, manchmal liegt das Beste direkt vor einem, und man erkennt es nicht, ich habe eine tolle Freundin, und darauf werde ich meine Aufmerksamkeit nun richten. Nochmals vielen Dank, bis Freitag.

XY

Beispiel 2:

Guten Abend Herr Zulauf

Ich bin im Zug nach Z, wo es viele Tunnels hat, sodass das Telefonieren schwierig ist. Ich kann Ihnen kurz mein Anliegen schildern.

Ich bin seit der zweiten Hypnotherapie bei Ihnen total neben den Schuhen und fragte mich weshalb. In der Nacht bin ich hellwach, ohne konkrete Anliegen. Dann hatte ich einen Traum, wo ich mich in einem Gehege, Wiese mit hohem Zaun befinde und nicht mehr raus kann. So fühle ich mich auch, wie lahmgelegt.

Ich musste alle Projekte aufs Minimum reduzieren, um noch das Minimum auf die Reihen zu bringen. Ich kam ja zu Ihnen mit der Frage, was blockiert mich, um voll im Leben zu stehen. Seit der ersten Sitzung ist die Beziehung zu XY freier, aber seit der zweiten Sitzung geht es mir nicht gut.

Ein Freund von mir erzählte mir von seiner Hypnotherapie; er habe sie mit dem Handy aufgenommen und nachher mehrmals gehört. Hätte ich das vielleicht auch machen sollen? Ich verstehe zu wenig von Hypnotherapie. Oder Sie hatten da eine CD zur Vertiefung oder wofür ist diese gut?

Dies wären meine Fragen.
Liebe Grüsse, XX

Antwort

Liebe Frau XX

So, wie ich mich erinnere, waren Sie vor der zweiten Sitzung sehr aufgewühlt (nach einem Gespräch mit einer Homöopathin?). Nach der zweiten Sitzung erlebten Sie sich gegenüber XY freier, aber spürten auch grössere Ängste um sie. Sie haben sich wohl in dieser Zeit voller zu diesem Muster Ihres Lebens geöffnet, die bisherige Balance verschoben und noch nicht wieder das Gleichgewicht gefunden, das dann auch im Positiven Ihre Veränderung bedeutet.

Bei grösseren Themen braucht es doch einige Sitzungen Hypnotherapie. Das Wort ‚Blockade' sagt ja nichts aus darüber, ob im inneren Geschehen eine einfache oder komplexe Disposition vorhanden ist. Ihr tragischer Zwillingshintergrund mit der aufgedrängten Schuld der überlebenden (Rechtfertigung zu überleben) und der Zwillingshintergrund von Alex kann ja wirklich mehr als genug Ihre Befangenheit und Ängste erklären.

Möglicherweise gibt uns Ihr Traum einen wichtigen Hinweis (so mehrdeutig Träume auch gewöhnlich sind). Die Wiese könnte Ihrem (zu engen) Spielraum entsprechen. Der hohe Zaun kann dann für die Grenzen stehen, die Sie überwinden versuchen. Jedoch auch - paradoxerweise aus Sicht des bewussten Verstandes - als Schutz. Schutz davor, ein Gleichgewicht zu verlassen, das Sie geschaffen haben. (Es ist ja oft bei grösseren Themen so, dass im Prozess des Öffnens und des Veränderns nicht einfach beliebige Ressourcen fertig zum Abholen im Innern bereit stehen.....).

Die Höhe des Zaunes hat vielleicht auch mit dem Druck zu tun, wie Sie die Veränderung anstreben. Oder auch mit einer gewissen Einseitigkeit der Dominanz des Rationalen und bewussten Willens, wie Sie bislang sich durchs Leben gesteuert haben.

Auf einer anderen Ebene mag dies auch dem Druck auf das vegetative System entsprechen und so z.B. die entsprechenden Ängste erklären. Ebenso mag dieser Druck auch bewirkt haben, dass Ihr Schlafverhalten - das Absinken - vorübergehend gestört war. (Mit dem Vegetativen geht ja das unwillkürliche Geschehen - das von selbst - in unseren Körper einher, eben z.B. das Schlafverhalten.

Gewöhnlich ist es dann so, dass je mehr es gelingt, bezüglich der Selbstbeeinflussung mit den Gedanken und Bildern, eine organische Entwicklung zu denken, werden in der Regel die Gefühle auch ressourcenvoller. Wenn wir eine spontane Szenerie aufgreifen (ist für uns sehr wertvoll, weil Sie diese ja kreiert haben) wie diejenige des Traumes, dann könnte es plausibel sein, sich nicht nur den Zäunen, sondern auch der Wiese zu widmen (nimmt Druck weg in erster Linie raus zu müssen).

Bezüglich CD: Einzelne Klienten nehmen auch bei mir die Sitzungen auf. Diese CDs oder dann noch mehr die Selbsthypnosen, die viele meiner Klienten nach ein paar Sitzungen anwenden, wirken umso mehr als sich eine Lösungsrichtung entwickelt hat und die Klienten selber die Anregungen, die sich dann zu Hause geben vor allem auch fühlen, dass sie das innere Geschehen erreichen.

Die CD, die ich oft abgebe, hat sich bei vielen Klienten als günstig erwiesen, als Hintergrund bei ihren Selbsthypnosen zu wirken (es sind keine spezifischen Suggestionen für einen Problembereich darauf).

Da Ihr Hauptthema aus hypnotischer Sicht auch Spontanität, Fliessen lassen, Fluss erweitern, neue Grenzen finden umfasst, warum nicht Bilder sehen und spüren von der Quelle zum Bach zum Fluss in allen möglichen Formen bis zum Meer und in jeder Phase beides sehen und spüren - Fliessen als Ufer. Das Offene als auch die natürlichen Grenzen.

Ich hoffe sehr, dass sich Ihre Befindlichkeit bald wieder ins Ressource volle bewegt.

Schönes Wochenende & herzliche Grüsse

Erich Zulauf

Beispiel 3:

Guten Tag Herr Zulauf

Letzten Freitag hatte ich einen Termin bei Ihnen. Leider bekam ich schon auf dem Nachhauseweg einen Migräneanfall und stehe seither völlig neben mir und habe alle zwei Tage Migräne-Attacken mit den bekannten Sehstörungen. Ich bin dermassen angespannt (körperlich und emotional). Mein Kopf steht immer auf Empfangen und ist völlig überreizt.

Als ich bei Ihnen aus der Praxis lief, fühlte ich mich eher wie die ‚kleine Fabienne' als wie eine erwachsene Frau. Im Alltag funktioniere ich, aber ziemlich ohne Emotionen (zumindest ohne positive).
Ich werde heute Nachmittag zum Osteopathen gehen, da ich auch körperlich völlig steif bin.

Kann eine Sitzung bei Ihnen so etwas auslösen?
Gibt es etwas, dass ich tun kann, um wieder etwas los zu lassen?

Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
Freundliche Grüsse und ‚en Guete'

XXX

Antwort

Hallo Frau XXX,

Zuerst mal tut es mir leid zu lesen, dass Sie von Migräne geplagt wurden! Als Nachwirkung einer Sitzung? Selten in dieser Intensität, jedoch es kann ein Aspekt des Prozesses sein.

Zu Beginn der letzten Sitzung sagten Sie, dass gelöste Gefühle (Gelassenheit, Freude etc.) noch nicht zurückgekehrt sind. Während der Trance jedoch hatte den Eindruck und Hinweise, dass sich eine freundliche Atmosphäre ausbreitete (Sie lächelten in Trance). Jedoch beim Hinausgehen wirkten Sie wieder in Spannung.

So haben wir es sicher noch nicht geschafft, eine Daueranspannung und vermutlich Verdrängungen, die weit zurückreichen, lösen, dass der Körper nicht auf Symptome ‚ausweicht'. Wie wenn Sie als Ganzes in sich noch nicht genug ‚Spielraum' dazu hätten. Wozu jedoch auch in den Sitzungen angeregt wird.

Möglicherweise waren die Anregungen der letzten Sitzung einfach zu intensiv (was nicht ganz einfach ist ‚genau' zu kalibrieren.

Was Sie machen können: In einem ruhigen Moment sich Zeit nehmen, zurücklehnen und sich ‚balancierende' Bilder zuführen. Z.B. wie ein aufgewühltes Meer wieder seine Wogen glättet. So ca. 10 Wellen in sich und vor allem durch Schultern, Nacken, Kopfansatz und dann den ganzen Kopf ‚durchfliessen' lassen. Möglichst mit einer einladenden Haltung (nicht erzwingen wollen).

Wenn Sie gedanklich abweichen, einfach wieder zurücklenken zu den Wellen. (So es ist mir z.B. auch schon gelungen eine entstehende Migräne einer ‚Migräne-Klientin' in der Praxis selber abzufangen. Diese Klientin hat beim Betreten der Praxis mitgeteilt, dass Sie entsprechende Kopfschmerzen zu spüren beginnen würde.) Auch weiteren Klienten ist diese 'Wellenrezept' schon nützlich gewesen, damit zu lernen selber eine beginnende Migräne abzufangen und wieder in angenehme Kopfempfindungen zurückzukehren.

So wünsche ich Ihnen, dass sich Ihr Wohlbefinden bald wieder auf das bestmögliche zur gegebenen Zeit einpendelt und dass für Sie als Ganzes (Körper, Unbewusstsein) diese Tage ein wichtiger Schritt in der Selbstheilung darstellt.

Herzliche Grüsse, Erich Zulauf

Antwort

Guten Abend Herr Zulauf

Vielen Dank für Ihr E-Mail; die Worte haben mich ziemlich berührt.

Ich werde das mit den Wellen ausprobieren.

Einen schönen Abend.

Herzliche Grüsse
XXX

7 Dissoziation

Das Phänomen welches allen höheren Lebewesen gemeinsam ist stellt eigentlich ein Paradox dar. Denn einerseits ist in uns eine Dynamik aktiv, welche uns zu einem ausgewogenen Ganzen anhält, doch anderseits muss man, um dies zu erreichen, sich von Störendem befreien, kurz: Dissoziieren.

Das menschliche Leben ist so komplex geworden, dass sich auch das Dissoziations-Geschehen teilweise stark individuell entwickelt, was grosse Störungen mit sich bringen kann. Deshalb kommt der **Dynamik** vom **Optimieren** von **Dissoziationen** grosse **ökologische Bedeutung** zu.

7.1 Veränderung von Dissoziationsmustern

Bei der Veränderung von Dissoziationsmustern lösen wir die Dissoziation auf, setzen die Dissoziation gezielt ein oder kombinieren beides.

Grundsätzlich können wir aktuell unter einem Dissoziationsmuster leiden, welches uns z.B. vormalig von externen dramatischen oder einseitigen Einflüssen geschützt hat. Ein solches Dissoziationsverhalten mag dann nicht mehr in die gegenwärtige Zeit hinein passen. Sehr häufig sind damit auch somatische Probleme verknüpft.

Je früher im Leben solche Dissoziationen auftreten, bzw. von Nöten sind, umso öfters werden diese auch von Dissoziation bezüglich der Beeinträchtigungen von Zuständen und Funktionen wie z.B. dem Selbstvertrauen, dem Lernen etc. begleitet. Bei Beschwerden lohnt es sich, diese Dissoziationsmuster auf passende Art und Weise aufzulösen. Sind Traumata mit der Dissoziation verwoben, muss diese Auflösung von einer Trauma-Behandlung begleitet werden (s.a. Pattern B des Hypno 3).

Deshalb ist man als HypnoCoach jeweils bestrebt, die **Ressourcen** des **Klienten** (durch Dissoziation eingeschränkte Funktionen und Zustände) zu **integrieren** und **gleichzeitig** jedoch auch **Traumatisches** (das, was die Dissoziation ausgelöst hat) **abzuschwächen**.

Im Verlauf des Lebens sowie auch während einer Hypnose kann ein abruptes Lösen einer Dissoziation auftreten. Dies wir oft innerlich als sehr intensiv bis tumultuöse erlebt.

7.2 Dissoziationen Re-assoziieren: Pattern A

(Pattern B im Hypno 3)

Finden wir ein Dissoziationsmuster vor kann es lohnenswert sein, dieses zu verändern, da damit in der Regel Ressourcen re-integriert werden.

Ist es offensichtlich, dass Ressourcen emotionaler, kognitiver oder perzeptiver Art fehlen und nicht verfügbar gemacht werden können **obwohl** keine traumatische oder phobische Dynamik vorliegt, ist der Fokus der Veränderung des Dissoziationsmusters auf das **Lösen der Dissoziation und dem Assoziieren des Fehlenden** zu legen:

- Der Prozess des Lösens der Dissoziation und der Integration des Dissoziierten kann in allen Variationen von bewusst bis zu unbewusst erfolgen.
- Dabei kann die bewusst erlebte, kognitive Aktivität beim Assoziationsvorgang im Visuellen, Auditiven, wie Kinästhetischen oder in Kombinationen der Sinnessysteme stattfinden.
- Über was wir uns ganz im Klaren sein müssen, ist die Ökologie der Veränderung für den Klienten D.h. wir fragen uns (und allenfalls auch den Klienten), ob das UBW in dieser Angelegenheit kooperiert und die positive Absicht des dissoziativen Musters auch nach der Veränderung gewahrt bleibt.
- Mögliche Ursachen für den Pattern A-Typus können bspw. einseitige Erziehung oder Identifizierung (Symbiose) mit relevanten Menschen (Eltern) sein.

Als dissoziative Muster kommen in Frage:

- Ein Bereich, der zu deinem Leben gehören würde, jedoch bis jetzt nicht erreichbar ist
- Ein Lebensabschnitt in dem du dich für dich selbst unüblich verhältst, es dir gesagt oder bedeutet wird.
- Das Erleben von unwillkürlichem Verhalten oder Denkprozessen, welche normalerweise vom bewussten Willen kontrolliert werden.
- Solche Prozesse können auch bei völliger Bewusstheitsabwesenheit stattfinden.

Als HypnoCoach nutzt man UBW-Signale, um auch ohne Wissen des BW den folgenden Prozess durchführen zu können.

7.3 Übung 8: Jäger des verlorenen Schatzes

1 B identifiziert bei A ein **dissoziatives Muster** (z.B. abgespaltene Emotionen). B eruiert, auf welche Weise A das Muster repräsentiert und welche **transformative Flexibilität** im Bereich des Musters vorhanden ist. Symbolisch, imaginative, visuelle, auditive oder kinästhetische Präferenz?

2 B lässt A in Trance den Sinn für ihre **Ganzheit** finden, am besten als Erlebnis auf allen Sinnesmodalitäten. Dies dient als **Rezeptorstruktur** für den Persönlichkeitsbereich, der mit der Auflösung des dissoziativen Musters verfügbar wird.

3 B lässt A hypnotisch den **Zugang** zur unbewussten Dynamik (Regie) des dissoziativen Musters herstellen. Dabei versichert sich B der **Kooperation** des UBW und findet die **positive Absicht** (Sekundärgewinn) des Musters. Ist die Regie fähig und willens, den dissoziierten Bereich zu integrieren?
- Wenn ja, weiter mit Punkt 5.
- Wenn nein, weiter mit Punkt 4.

4 Vorgehensweisen:

a) Bei **Unfähigkeit** wegen **‚nicht wissen wie'**: Instruieren, evtl. einen Zeitplan für den Fall erstellen, dass die Integration mit Üben verbunden ist.
b) Bei **Unfähigkeit** wegen **‚traumatischem Material'**: Eine hypnotische Trauma-Arbeit vornehmen, WSK oder einfach die Ressource, welche die Person heute, **jetzt** hat -> in den Zeitraum des Traumas zu führen (mehr zu Traum-Arbeit im Hypno 3).
c) Bei **fehlender Bereitschaft**: Reframen, verhandeln etc.

5 Initiieren des **Integrationsprozesses**. Nun über längere Zeit vor allem **transneuronal** sprechen, d.h. Schlüsselbegriffe **mit** transneuronalem Sprechen verbinden.

6 Prüfen der **Ökologie** (Einwände, positive und/oder negative Effekte). Wenn erforderlich (nochmals) eine Runde Behandlung der Einwände und/oder Reframen, verhandeln.

7 Nochmals **transneuronal** sprechen mit **posthypnotischen Suggestionen**.

8 Reorientierung mit Feedback und Ratifikation.

8 Mit Hypnose und High Quality Information zu Tranceformation 2

8.1 Ein Hauch von Schamanismus

Zentral im schamanistischen **Heilungsritual** ist die **Identifikation** mit dem **Objekt**. Es ist kein zufälliges Objekt und **unterliegt** einer **Raum/Zeit – Besonderheit**. In diesem Jetzt und Hier wird die **Ich-Du–Grenze aufgehoben**, so dass der **heilende Einfluss** des **Objekts**, welches **Stellvertreter-Bedeutung** für **Ganzheit (Heil-Sein) besitzt**, geltend gemacht werden kann.

Dieses Objekt, das vom Schamanen intuitiv ausgesucht wird oder intuitiv vom Leidenden selbst, ergänzt den Leidenden zur geheilten Ganzheit. Entsprechend dem Bezug der Ganzheit kann die **Vernetzung** zum **kosmologischen Gedankengut** von **grossem Wert** für eine **heilende Entwicklung** sein. Schamanismus entspricht einem Konzept der Naturvölker, das vom magischen Bewusstsein geprägt ist.

Im Zusammenhang mit der Stellvertreter-Bedeutung für Ganzheit erinnern wir an das Konzept des Hinduismus. Dieses geht davon aus, dass wir alle **in uns eine Entsprechung** (Atman) des **Göttlichen** (Brahman) haben (**sind**). Diese Entsprechungen sind natürlich unaussprechlich. Doch können einige ganz von sich selbst aus und alle anderen ganz bestimmt über die rechte Hemisphäre ihres Gehirns, für einen Moment einfach das sein, was man selbst mit dem Inbegriff des Göttlichen oder des Kosmischen assoziiert.

Nun, da jeder **Mensch funktionelle Hirnbereiche** aufweist, welche vornehmlich **auf Ganzheit aus** sind und dem **magischen Denken** nicht abhold, beinhaltet dies, auch in unserer **modernen Zeit,** eine **Ressource** gerade bei **körperlichen Symptomen**, mit welches wir uns **heilen** zu können.

Über die Hypnose mit ihrem Bezug zu den Aktivitäten des UBW, kann man eine gelungene Synthese von der ursprünglichen Heilungskunst der Schamanen und den Errungenschaften unserer postmodernen Zeit vollziehen.

Gut zu wissen ist auch, dass man nicht die ganze Zeit so absolut das **Objekt** zu sein braucht, sondern nur **ehrlich und voll und ganz** von Zeit zu Zeit in der Trance.

Beispiel:

Einem bleichen, aufgeschossenen jungen Studenten, dessen Knie über 10 Jahre hinweg nicht zuheilte und nicht belastbar war, **half die Identifikation in der Trance mit dem Tiger**. Auf der simplen Grundlage, dass das Knie des Tigers noch weiss, wie es sich heilen kann und ganz im Sinne davon, dass der Tiger Natur pur ist. Der Student lernte sich bei sich zu Hause selbst zu hypnotisieren, sogar mit Handlevitation. Nach etwa 1/2 Jahr war das Knie geheilt und wieder belastbar (z.B. für Hockey und Basketball).

8.2 Übung 9: Be it!

1. A denkt an einen Aspekt ihrer Persönlichkeit, welcher Zuwendung bedarf. Es kann sich um etwas Psychisches wie auch Körperliches handeln.

2. B ruft (elizitiert) ein Objekt der unmittelbaren Faszination von A in A hervor. Kennt A nicht schon eines für sich, lässt B A in der Trance auf die Suche nach diesem Objekt gehen..... eine Pflanze, ein Tier, eine Landschaft, ein Mensch, ein Fabelwesen etc.
   Dies ist eine Art der transderivativen Suche: **Ausgehend vom Bedürfniszustand wird nach einem Objekt zur (Wieder-)Herstellung der individuellen Ganzheit gesucht**.

3. B lässt nun A sich in der Trance mit dem Objekt identifizieren – dieses Objekt werden. Dabei nimmt sich B Zeit, gerade den Bereich auszuloten und zu betonen, der Zuwendung bedarf.

4. Gleichzeitig aktiviert B eine zweite Ebene der Kommunikation mit A, z.B. Fingersignale, Handlevitation etc. um Hinweise vom UBW zu erhalten, welche den Prozess des inneren Verständnisses, Heilens etc. betreffen. Kurz: Es wird eine wirksame Trance angestrebt.

5. Fühlt A (UBW) sich **ganz** bezüglich des Themas oder **so ganz wie nur möglich** für diesen Moment, so regt B posthypnotisch die Selbstregulierung dieser Dynamik in A an.

6. B eruiert die Befindlichkeit von A nach der Trance. Wie äussert sich A nun im Themenbereich etc.

8.3 Transneuronale Welten

Veränderung hat immer auch mit Lernen zu tun. Die Hirnforschung hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass während des Lernens und Erinnerns sogar auf der Stufe von Dendriten und Synapsen physische Verbindungen im Gehirn geknüpft werden.
Zur Information: Verbindungen zwischen den Neuronen werden Synapsen und die Fortsätze von Neuronen werden Dendriten (bis 1000 / Neuron) genannt.

Hypnose ist das System, welches sich am besten eignet übliche innere und äussere Assoziationen (Attribute, Auslöser, Cues) zu lösen und neue bilden zu lassen.

Obwohl diese Prozesse auf der neurophysiologischen Ebene noch nicht ganz verstanden sind dürfen wir annehmen, dass es sich dabei um Prozesse handelt, bei denen so etwas wie **neue Bahnen**, **Verbindungen** zwischen den Hirnzellen gelegt werden bzw. dass auf verschiedene Arten neue **Verknüpfungen** zwischen den Hirnzellen gebildet werden.

Sind wir während der Trance fähig, diese Phase der Neuvernetzung zu beeinflussen, so erhöht sich damit die Chance der Nachhaltigkeit der Veränderung.

Was brauchen wir dafür für Ingredienzien?

- Erkennen der TrancePodi (Attribute) und Auslöser von unerwünschten Verhalten beim Klienten.
- Trance, Intervention der Veränderung, Musterunterbrechung, Metaphern etc.
- Posthypnotische Suggestionen
- Vernetzungsphase - den Dritten finden

Es geht darum, dass wir dem Gehirn die Gelegenheit geben, nicht nur neue Information auf gewohnte Art und Weise zu verknüpfen, sondern auch **neue Wege der Verknüpfung** von neuen und alten Informationen zu finden. Gestützt wird diese Ansicht nicht zuletzt im Befund, dass in der menschlichen Entwicklung Babys am meisten Synapsen aufweisen. Auch in der intensivsten **Lernphase von Erwachsenen** legt das **Gehirn** offenbar **mehr Wert** auf die **Koordination** des **neu Gelernten** als im puren Speichern selbst.

Die Bedeutung dieses Ansatzes wird von Untersuchungen unterstrichen, dass Ungeübte und weniger ‚Lösungs-Intelligente' Menschen beim Lösen komplizierter Probleme ihr Gehirn mehr beanspruchen als Geübte oder ‚Lösungs-Intelligente'.
Die Erklärung dazu ist einfach, denn für das Gehirn gilt: Je weniger Aufwand, desto besser. (Normalerweise meint man das Gegenteil.)

Hintergrund dieser Erklärung ist, dass die **zeitliche** und **inhaltliche Begrenztheit** des **Arbeitsgedächtnisses** und die **Begrenztheit** des **Aufmerksamkeitssystems**, **Engpässe** für die **Intelligenz** zu sein scheinen. ‚Lösungs-intelligente' Menschen aktivieren ihr Gehirn weniger stark als weniger Lösungs-intelligente um ein bestimmtes Problem (besser) zu lösen. Dies geschieht indem sie den ‚Engpass' des Arbeitsgedächtnisses in kürzerer Zeit durchlaufen. Kurz: Sie nutzen ihre zerebralen Ressourcen besser (z.B.: Roth: Fühlen – Denken –Handeln, Suhrkamp, 2001).

8.4 Die wirksame Trance

Erstaunlich ist es, tatsächlich, dass leichteste Trancen grosse Wirkung haben können. Anderseits können so genannte Tieftrancen, in denen Menschen wie ‚weg' sind, völlig wirkungslos bleiben.

➔ Deshalb brauchen wir im Rahmen der Hypnose 1 - 3 den Ausdruck **wirkungsvolle Trance**.

Doch, wie erkennen wir nun eine wirkungsvolle Trance?
Etwas banal gesagt natürlich vorwiegend dadurch, dass die Trance nach der Hypnose ihre Wirkung zeigt.

Nun ist es verständlich, dass beim erstmaligem Hypnotisieren, und auch wenn wir einen Menschen nicht wiederholt hypnotisiert haben **und** uns entsprechende Resultate vorliegen, können wir im Hypnosegeschehen gewöhnlich nicht bewusst sicher sein, dass die Trance Wirkung haben wird.

Es kann auch vorkommen, dass wir in vielen Fällen einige bis viele Male mit einem Menschen arbeiten, ohne dass sich kurzfristige Resultate zeigen.

Welches sind in diesen Situationen mögliche Hinweise auf eine wirkungsvolle Trance?

Einige **Kriterien** einer wirkungsvollen Trance:

- Bei grosser Erfahrung des Hypnotiseurs die Intuition, vielfach ein Gefühl.
- Information aus der Trance des Du in mir (Hypno 3).
- Ideomotorik, Armlevitation, Katalepsie.
- Beschrieb des Klienten, z.B. Bilder der Veränderung, Gefühle und Empfindungen im Zielbereich (bei Symptomen).
- Linderung oder Lösen eines Symptoms während und/oder nach der Trance.
- Signale des UBW auf Anfrage.
- Prozesshinweise, z.B. stark veränderte Befindlichkeit des Klienten im Verlauf der Hypnose (von gestresst bis ruhig, von apathisch bis lebhaft etc.).
- Zunehmende Entflechtung von BW und UBW innerhalb einer einzigen Trancearbeit oder im Verlauf von sich nachfolgenden Sitzungen.
- Hypnotische Träume.

Wir gehen also nicht von einer statischen, starren Idee zu Trancen aus, sondern lassen Trancen sich immer im Rahmen individueller Gegebenheit entwickeln.

9 Wie sag‘ ich es meinem Kinde? (WSK)

Es ist ein offenes Geheimnis, dass viele unserer grösseren Probleme und Symptome in unserer Kindheit wurzeln. Eine der grössten Nutzungsmöglichkeiten der Trance besteht nun darin, dass wir nicht analytisch erörtern, was denn da in der Kindheit wohl passiert sei, sondern Kontakt mit dem betreffenden, jüngeren Selbst (Kind) aufnehmen und es sich neu erfahren lassen.

Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir uns selbst in der Kindheit begegnen und uns neu beeinflussen können.

Voll identifiziert als Kind

Identifiziert sich die Versuchsperson stark mit dem jeweiligen Lebensalter können wir direkt zum Kind sprechen. Man kann dabei offenlassen, wer es ist, der da spricht. Dabei kann der Hypnotiseur als **Bezugsperson** auch eine **fiktive**, **integre Person** in die **Szene** einfügen, in der sich das **Kind** befindet.

Sich gleichzeitig als Erwachsen und als Kind am Ort der Kindheit erfahren

Recht häufig tritt in der Trance die Variante auf, dass die beiden Selbst, das gegenwärtig und kindlich, gleichzeitig präsent sind. Der Klient kann dabei zwischen beiden Zuständen hin und her wechseln und der Hypnotiseur kann zu beiden sprechen, je einzeln oder gleichzeitig.

Häufig ist es sinnvoll, das Kind aus den 'alten Filmen' austreten zu lassen oder es rauszuholen und neue Szenarien zu entwickeln (neue Filme) – also eine neue Vergangenheit entstehen zu lassen. Für eine bessere Kindheit ist es nie zu spät!

Den Erwachsenen in Trance und das Kind in die Gegenwart nehmen

Oft genügt es schon das Kind in der Gegenwart vor sich zu imaginieren und ihm passend in der Gegenwart zu begegnen. Dieser Ansatz kann uns schon viele Info geben, kann also ‚diagnostisch' verwendet werden.

9.1 Übung 10: Wie sag‘ ich es meinem Kinde? (WSK)

1 **Symptom/Problem**

A benennt ein Problem/Symptom bei dem er/sie weiss oder ahnt, dass ein jüngeres Selbst mit im Spiel ist.

B spielt kurz das WSK konversationell durch (Instruktion dazu im Kurs).

2 **Trance**

B führt A in Trance und in die Kindheit.

3 **Regression**

B eruiert, wie A diese Regression erlebt:
Als Kind (A) oder als Kind und Erwachsene(r)?

4 **Change A**

B beginnt das Kind von A zu kontaktieren oder lässt es einer erwachsenen, integren Person begegnen und lädt es in einen neuen Kontext ein. Zuerst wird der Kontakt betont, dann eruiert was das Kind braucht. Es wird dem Kind gegeben was es braucht um seinen Zustand in eine ihm nützliche Richtung zu verändern.

5 **Change B**

Der Kontakt wird zwischen dem Erwachsenen, evtl. auch über das Erwachsene-Selbst aus der Zukunft (alternativ auch mit einer zusätzlichen Ressource-Person) und dem Jungem-Selbst hergestellt. Dann wie 4.

6 **Integration** Den neuen, ressourcenvollen Zustand im erwachsenen Organismus, mit Hilfe von weiteren Ressourcen, in die Zukunft und in die Vergangenheit ausbreiten lassen.

7 **Reorientierung**.

Was, wenn..... bei WSK

Im Falle dessen, dass während der Identifikation mit sich als Kind traumatisches Material aktiv wird oder die traumatische Dynamik überhandnimmt, ist auf eine mögliche **Hyperventilation*** des Klienten zu achten, welche nicht selten als Teil des traumatischen Ausagierens vorkommt. Dabei ist es wichtig angemessen intervenieren zu können.

Was können wir tun?

1 Bonding

Bonding bedeutet, auf passende Art und Weise den Klienten zu berühren. Bonding hilft dabei, dass sich die Person unterstützt fühlt. Bonding bedeutet für sie einen Kontakt nach aussen und den Bezug zur Gegenwart zu erhalten.

2 Atemberuhigung

Besonders bei Hyperventilation dafür sorgen, dass sich der Atemrhythmus wieder beruhigt. Z.B. Hand auf Rücken oder Hand leicht über Nase legen etc.

3 Dissoziation

Sofort ein Trennen des erwachsenen Selbst vom jungen Selbst.
Dies wird erreicht indem angeregt wird, dass das erwachsene Selbst in der Gegenwart gestärkt wird und zusätzlich z.B.:

- Das Kind aus der Szene herausgenommen wird oder
- Die problematische Szene auf eine Filmleinwand projiziert wird, das Kind also mit all seinen Ressourcen und Potentialen aus der Szene herausgenommen und der Rest geschreddert (o.ä.) wird (siehe auch schnelle Phobie-Technik des NLP).

4 Integration Hat sich die Person beruhigt, kann, wie in den Unterlagen und im Kurs mittels zusätzlicher Information vorgeschlagen, im integrativen Sinn weitergearbeitet werden.

10 Symbolisch, metaphorisch kommunizieren

10.1 Übung 11: In Trance erzählen

1 A benennt ein Problem.

2 B regt zu einer leichten Trance an.

3 B hilft A nun zu assoziieren: Ist das Problem rot oder schmutzig-braun? Handelt es sich dabei um einen Ton oder ein Gefühl/Empfindung?

Ist es ein Haus oder ein Boot?Gibt es eine Geschichte (Bspe. machen), an die das Problem dich erinnert?

4 B macht nun mit A ein nonverbales Signal für 'Ja, es passt' ab (UBW oder BW).

5 Nun bietet B A Anregungen zur Assoziationsentwicklung an. Dabei unbedingt 'wohlwollend-erlaubende' Worte anwenden!

Denn, es ist möglich, dass A eine eigene Assoziationsspur findet. Durch eine einengende Wortwahl würde A allenfalls bei der Entwicklung dieser gestört werden. Bleibt der Sprachgebrauch von B jedoch ‚wohlwollend-erlaubend' und die Anregungen damit fakultativ, kann A sich auf der Analogieebene inspirieren lassen und gleichzeitig eine eigene Lösung entwickeln. Ziel ist, auf diese Weise die Problemeinstellung in Richtung Lösungseinstellung zu bewegen.

Bspe.: Das Problem ist schmutziges Braun. – Schmutzig-braun wie Hundekot? oder wie der verschmutzte Ganges? Oder der vom Regen aufgewühlte Jang-Tse?

.....weißt du, dass sich die Partikel im Fluss allmählich wieder auf den Grund senken und so das Wasser wieder klar wird?Bsp.: Ist das Problem ein Haus, das schlecht isoliert ist, ohne dass es die Bewohner merken oder sich der Konsequenzen gewahr sind etc.?

10.2 Übung 12: Geschichten, die heilen

Im Kurs lernen wir **Metaphern**, **Analogien** und **Geschichten** auch **spontan entstehen** zu lassen. Allerdings ist es hilfreich, ein paar wichtige Strukturelemente wie **Isomorph Ismen** (Entsprechung eines Bewusstseinszustandes mit einem äusseren Bild, Konstrukt) einzubeziehen. In der **Metapher** stellen wir **Schlüsselaspekte** der konkreten **Gegebenheiten** des **Klienten** durch entsprechende **Repräsentationen** (Analoge) dar: Z.B. wird eine Familie durch eine Regierung repräsentiert (die Mutter ist der Premier, der Vater der Arbeitsminister etc.).

Hingegen ist es bei Themen, bei denen es z.B. um ungünstige Überzeugungen, Depression oder auch Zwangsstörungen geht, entscheidend, den Klienten in erster Linie bezüglich der ungünstigen Einstellungen durch Staunen, Humor oder Schein-Plausibilität zu verunsichern. Dabei müssen die Isomorph Ismen jedoch nicht unbedingt genaue angewandt werden.

Im Gegensatz dazu ist es bei körperlichen Krankheiten wie Krebs, entzündlichen Darmkrankheiten oder Autoimmunerkrankungen sehr wohl angezeigt, sehr genaue Analogien zur Dynamik welche sich im Körper abspielt zu verwenden.

Vorder-/hintergründig: Die Metapher wird entweder sehr wirklichkeitsnah (beispielhaft) oder symbolisch konstruiert.

Metapher-Entwicklung: Vom dargestellten Problem zur Entwicklung und Lösung.

Signale: Wenn möglich laden wir das UBW ein, mit Signalen zu bestätigen, ob die Metapher für das UBW als nützlich erachtet wird.

Hypno-Refrain: Sobald die Geschichte ‚greift', wird der Redefluss mit Refrains durchsetzt, d.h. diejenigen Elemente der Geschichte, auf welche die Person stark positiv reagiert, werden wie ein Refrain eines Liedes wiederholt.

Ablauf

1 A und B interviewen einander (nacheinander) bezüglich eines Themas, Problems oder Symptoms.

2 Dann nehmen sich A und B Zeit, um eine Metapher mit Einbezug von Isomorphismus zu formen, vorder-/hintergründige. Sie erinnern sich dabei auch an einige hypnotische Sprachmuster welche sie anwenden werden.

3 B geleitet A in Trance, etabliert Signale und erzählt die Geschichte.

4 Sobald A sich in die Geschichte involviert und eine stabile Trance vorhanden ist, beginnt B mit den Refrains.

5 Feedback, betrifft vor allem Trancetiefe, Signale und den Sinn etwas Wichtiges gehört zu haben.

11 4-Steps

Um einen optimalen Zustand für einen bestimmten Anlass oder auch kontinuierlich verfügbar zu haben, lohnt es sich die passenden Aspekte zu bündeln. Wie so vieles, was wir lernen möchten, geht auch hier ohne ein Eintrainieren nicht allzu viel.

11.1 Übung 13: Das 4-Steps-Programm des Auftritts

(Punkte 1 - 4 können verbunden werden mit einem Punkt oder Kreis auf dem Boden. Beim zunehmend verfügbar werden des entsprechenden Gefühls, Bildes (Farbe), Wortes oder Satzes kann dann auf den Punkt gestanden oder in den Kreis getreten werden. Dies fördert die Kompaktheit, Intensität und Erinnerungsfähigkeit des Arbeitsgedächtnisses „Auftritt“.)

1 Assoziation der Stärke: Verbinde dich mit deinem Grundgefühl, ev. in leichter Trance. Dazu kannst Du auch d(ein) Krafttier wählen! Addiere dazu passende Emotionen.

2 Referenzerfahrung: Denke an Situationen, wo dieselben oder ähnliche Erfordernisse zu bestehen waren und es gut ging. Dieses Gefühl mit denjenigen von (1) kombinieren.

3 Zugang zum Gedächtnis: Nun den Gedächtnisinhalt (ev. Mindmap) bezüglich des Kontextes verfügbar machen. Dabei nur kurz an etwas Spezifisches aus diesem Gedächtnisinhalt denken.

4 Motivationssatz: Um sich nun bereit zu machen, es zu tun, finde einen Satz, der dich motiviert, z.B. „Ich geh und tue’s!“; „Ich geb mein Bestes!“ , etc.

Mit Vorteil verbinden wir den 4-Steps mit der nachfolgenden Übung „Vorbahnen“. Wir versetzen uns also in den optimalen State für die jeweilige Aufgabe / das Vorhaben und verbinden dies mit dem Rückwärtslernen.

11.2 Übung 14: Vorbahnen

Die SkifahrerInnen tun es und auch die BergsteigerInnen. Es ist ebenso erfolgreich einsetzbar bei einer Prüfung, einem Auftritt wie im Sport. Planen beispielsweise Bergsteiger einen Aufstieg sind sie gut beraten, wenn sie beim Gipfel, also mit der letzten Etappe anfangen. So vermeiden sie eine unangenehme Überraschung, nämlich z.B. kurz vor dem Gipfel eine überhängende Wand oder ein unpassierbares Eisfeld durch-, bzw. überqueren zu müssen.

Übung: Von hinten nach vorne denken (Rückwärtslernen)

Bsp.: Prüfungsvorbereitung

- Sich in guter Stimmung aus dem Prüfungszimmer gehen sehen.
- Sich in guten Gefühlen in den letzten 90% der Prüfungsehen.
- Sich in guten Gefühlen in der Mitte der Prüfung sehen.
- Sich in guten Gefühlen am Anfang der Prüfung sehen.
- Sich ganz am Anfang sehen, hinein zu gehen und genau sehen (oder deutlich hören) und verstehen, was geschrieben vorliegt (oder zu hören ist), was bezüglich Prüfungsaufgaben verlangt wird.
- Sich sehen und fühlen, wie kurz vor der Prüfung der Auftrittszustand eingespielt wird.

Siehe nächste Seite für deine Notizen

1. Durchgang 4-Steps: Platz für DEINE NOTIZEN

Welches Thema willst du bearbeiten mit dem 4-Steps?

1 Assoziation der Stärke (Grundgefühl, Krafttier, Kraftobjekt):

2 Referenzerfahrung:

3 Zugang zum Gedächtnis bezüglich des Kontextes verfügbar machen (evtl. Mindmap):

4 Motivationssatz: